

Cribado sistémico · Lumbar

PhysiQ-Assessment · fase 2. Preguntas literales de la app. Las listas de banderas rojas y amarillas de cada sistema están en la app.

URGENCIAS HOY · CAUDA EQUINA

- Urgencia quirúrgica: el tiempo hasta la cirugía pesa más que la duración de los síntomas.
- Dolor o debilidad bilateral grave en MMII · parestesia en silla de montar · retención o incontinencia urinaria · incontinencia fecal · menor tono anal.
- PREGUNTAR SIEMPRE. Signos más específicos que sensibles; RM de elección. En mayores con estenosis el inicio lento se solapa y pasa desapercibido.

Posquirúrgico

1. ¿Desde la operación, la herida está más roja, caliente, hinchada o dolorosa, supura o se ha abierto, o ha tenido fiebre, escalofríos o malestar general? **URGENCIA · derivar hoy**
2. ¿Desde la operación tiene una pantorrilla o una pierna hinchada, caliente o dolorosa? (Posible TVP: calcular Wells; ≥ 2 → probable.) **URGENCIA · derivar hoy**
3. ¿Desde la operación tiene una pantorrilla, una pierna o el brazo operado hinchados, calientes o dolorosos? (En la pierna, posible TVP: calcular Wells; ≥ 2 → probable.) **URGENCIA · derivar hoy**
4. ¿Le falta el aire de repente, le duele el pecho al respirar, ha tosido sangre o se ha mareado o desmayado? **URGENCIA · derivar hoy**
5. ¿Desde la operación, o desde que le pusieron un yeso, una férula o un vendaje, tiene un dolor intenso y desproporcionado que va a más, sobre todo al estirar los dedos, con la zona muy tensa, hormigueo o adormecimiento? **URGENCIA · derivar hoy**
6. ¿Tiene un dolor continuo y desproporcionado para la operación, con cambios de color, temperatura, sudoración o hinchazón en la zona, o le duele incluso el roce de la ropa?
7. ¿Desde la operación nota un dolor quemante, hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza nuevos en la zona de un nervio (por ejemplo, en la mano o el pie del lado operado)? **URGENCIA · derivar hoy**

Cáncer / Oncológico

1. ¿Tiene antecedentes de cáncer de cualquier tipo?
2. ¿El dolor nocturno lo despierta desde un sueño profundo y le resulta imposible encontrar una posición que lo alivie?

Urogenital / Renal

1. ¿Ha notado cambios en la orina (color rojo, marrón, turbio) o fiebre/escalofríos junto con el dolor de espalda?
2. ¿Presenta incontinencia urinaria o intestinal, o pérdida de sensibilidad en la zona de "silla de montar"? **URGENCIA · derivar hoy**
3. ¿En las últimas 3–4 semanas ha notado ardor o dolor al orinar?
4. ¿Desde hace poco se levanta a orinar más de una vez cada noche, sin que haya cambiado lo que bebe antes de acostarse?
5. ¿Ha tenido un dolor muy intenso en el costado o la zona lumbar, que va y viene a oleadas y baja hacia la ingle o los genitales, con náuseas o vómitos?

Gastrointestinal

1. ¿El dolor lumbar, sacro o pélvico se alivia o cambia después de tener una evacuación intestinal o al expulsar gases?
2. ¿El dolor está relacionado con su ciclo menstrual, tiene sangrado inusual o dolor que alterna con dolor abdominal?
3. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en las heces, o dolor que lo despierta entre la medianoche y las 3 am?

Espondiloartropatías / Espondilogénicas / Ginecológico

1. ¿Tiene rigidez matutina prolongada (más de 30 minutos) que mejora con el movimiento?
2. ¿El dolor cambia de un glúteo a otro, unas veces en un lado y otras en el otro?
3. ¿El dolor sigue igual o empeora cuando descansa, en lugar de aliviarse?
4. ¿El dolor sacroilíaco lo despierta en la segunda mitad de la noche (entre las 2 y las 5 am)?
5. ¿El dolor pélvico está claramente relacionado con el ciclo menstrual, o tiene sangrado ginecológico inusual?
6. ¿Tiene diagnóstico de osteoporosis, o ha tenido una fractura reciente ante un golpe menor o sin trauma aparente?
7. ¿Ha notado deformidad ósea, engrosamiento de huesos o ha sido diagnosticado de enfermedad de Paget?
8. ¿Hace deporte o actividad vigorosa y repetitiva (p. ej. correr) y el dolor de nalgas aparece con ella, con dieta pobre, alteraciones menstruales o fracturas de estrés previas?
9. ¿Ha aparecido de golpe dolor en ambas piernas durante el deporte, tras lesiones repetidas en extensión de la espalda?

Patrón compatible con dolor lumbar inflamatorio: derivación preferente a reumatología. — 2 o más de las preguntas 1, 4, 2, 3 · edad ≤ 45 · evolución: Crónico (>3 meses)

Vascular

1. ¿El dolor de piernas al caminar se le pasa con solo pararse de pie, sin necesidad de sentarse ni inclinarse?
2. ¿Tiene dolor lumbar o abdominal en reposo o por la noche, o le han notado un bulto que late en el abdomen?
3. ¿Nota un pie más frío que el otro, o le han dicho que tiene los pulsos de las piernas débiles?

Infección vertebral

1. ¿Ha tenido fiebre o alguna infección en las últimas semanas, le han operado o infiltrado la espalda hace poco, o tiene las defensas bajas (corticoides, inmunosupresores, VIH, diabetes)?

Endocrino / Metabólico

1. ¿Siente fatiga inusual o debilidad muscular, especialmente al subir escaleras o levantarse de una silla?
2. ¿Ha notado aumento anormal de sed, apetito o frecuencia urinaria (incluso despertándose por la noche)?
3. ¿Ha experimentado cambios recientes en su peso o tolerancia a la temperatura (mucho frío o calor cuando otros no)?
4. ¿Nota que sus heridas sanan muy lentamente o le aparecen moretones con excesiva facilidad?
5. (Si tiene diabetes) ¿Suele tener episodios de bajadas de azúcar, o siente ardor, entumecimiento o pérdida de sensibilidad en manos y pies?

Hematológico

1. ¿Sangra o se le forman moretones fácilmente después de un traumatismo menor, cirugía o procedimiento dental?
2. ¿Experimenta falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho con esfuerzos leves (subir escaleras) o en reposo?
3. ¿Padece infecciones recurrentes o fiebre baja frecuente (resfriados, gripe, infecciones respiratorias)?
4. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en orina, o ha tosido o vomitado sangre?

Un Sí aislado no implica derivación automática (salvo las preguntas de URGENCIA): evaluar en el contexto clínico completo. Generado desde los datos de la app el 7/10/2026.